

神経学的問診、診察、局在診断

概説と時間経過

- 病変部位、次に病的過程
- 整合する局在診断が検査を導く
- 最後に正常であった時刻を特定
- 発症時最大は塞栓、出血、発作、片頭痛
- 数時間から数日は炎症、感染、圧迫
- 数週から数か月は腫瘍、免疫、変性
- 反復定型的是てんかん、片頭痛、チャンネル病

偶発的画像所見は解剖に代わらない

症状の定義と背景

- 名称でなく失われた機能を問う
- 発作性事象は目撃者から聴取
- 血管危険因子、腫瘍、免疫、毒物、家族歴
- 抗凝固薬、鎮静薬、ドパミン遮断薬を確認
- 発症前の移動、認知、利き手、希望
- 危険徴候は雷鳴頭痛、髄膜刺激、括約筋障害

めまいは回転性、前失神、平衡障害
脱力は筋力、疼痛、疲労、協調障害

完全診察より安定化を優先

精神状態

- まず覚醒度と注意
- 記憶、言語、視空間、実行を問いに応じて
- 得点は教育、言語、文化の影響を受ける
- 急性変動と不注意はせん妄を示唆
- 失語と構音障害、難聴、覚醒低下の区別
- 意思決定能力は個別の決定ごとに評価

障害されると以降の検査は無効

運動系診察

- 筋量、線維束性収縮、不随意運動
- 異なる速度で筋緊張を評価
- 真の筋力低下と疼痛、疲労、脱力を区別
- 錐体路性は上肢伸筋と下肢屈筋優位
- ニューロパチー遠位、ミオパチー近位
- 接合部性筋力低下は変動し易疲労
- 反射亢進、クローヌス、伸展性足底反応
- 反射低下は正常変異もある

痙縮は速度依存性、固縮は均一
パレートニアは協力や前頭葉で変動

統合とコミュニケーション

- 一文で症候群、局在、機序、経過
- 不確実性を明示し診察を反復
- 運転、水辺の安全、転倒、嚥下
- 機能的神経症状症は積極的徴候で診断
- リハビリは診断と並行して開始

脳神経

- 視力、視野、瞳孔、眼底、眼球運動
- 相対的求心性瞳孔障害は非対称な視神経障害
- 乳頭浮腫は即時でも普遍でもない
- 上位運動ニューロン性は額を温存
- 口蓋、声、咳、嚥下の安全性

下位運動ニューロン性は同側顔面全体

下位脳神経障害は気道と栄養を脅かす

感覚系診察

- 分布を図示、閉眼、リズムと誘導を避ける
- 皮質性感覚検査は一次感覚と注意が前提
- 感覚レベルは脊髄
- 鞍部感覚低下は馬尾または円錐
- 皮節は神経根、固有神経、靴下型
- 顔面と身体の交叉性障害は脳幹
- 機能性は除外より積極的徴候

協調運動、立位、歩行

- 指鼻、踵膝、反復拮抗運動
- 測定障害は筋力低下や感覚低下でも生じる
- ロンベルグ試験は視覚なしの立位
- 異常でなく歩行パターンを記述
- 安全でない患者は介助下で検査

閉眼時転倒は固有感覚か前庭の障害

局在診断の枠組み

- 大脳半球は対側障害と皮質徴候
- 脳幹は脳神経徴候と対側身体徴候
- 小脳は同側協調障害、筋力低下なし
- 脊髄は病変以下の両側性徴候
- 馬尾は非対称な下位徴候、鞍部、括約筋
- 神経根は放散痛、筋節、皮節、反射
- 接合部とミオパチーは感覚障害なし

高位で下位、以下で上位運動ニューロン

半側損傷は対側の痛覚温度覚障害

検査

- CTは血液、占拠効果、水頭症、骨折
- MRIは梗塞、脱髄、後頭蓋窩、脊髄
- 緊急度は臨床的リスクで決定
- 偶発所見は多く診察と対応させる
- 腰椎穿刺は初圧、細胞、蛋白、糖
- 短時間の正常脳波はてんかんを除外しない
- 神経伝導検査は軸索性と脱髄性を識別

ヘルニアリスクがあれば先に画像

抗微生物療法を遅らせない